BC3 – Chapitre 1 : tout ce qu'il faut savoir

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition – fiche complète (à jour au 1er novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 1 : définitions, classifications, acteurs, politiques, chiffres, méthode de projet et pièges. Elle suit l'ordre du cours (1.3.1 à 1.4.5). Les erreurs repérées dans le cours ont été corrigées ici (stratégie nationale de santé, FFAMCO, numérotation du modèle de Dahlgren et Whitehead).

Ce qui est en **gras** est à savoir par cœur. Les chiffres sont toujours donnés avec leur source et leur année : citez-les de la même façon dans vos copies.

1. Les concepts de santé (1.3.1)

1.1 Les modèles, dans l'ordre

Modèle	Date, auteur	Idée clé	Limite
Biomédical	XIXe – milieu XXe siècle	Santé = **absence de maladie** ; cause biologique ; action curative et individuelle	Ignore le vécu et les causes sociales (obésité vue comme simple bilan énergétique)
Définition de l'OMS	**1946** (signée le 22 juillet 1946, en vigueur le **7 avril 1948**, Journée mondiale de la santé)	Santé positive, multidimensionnelle, et **droit fondamental**	« Complet » bien-être = idéal presque inatteignable ; vision statique
Biopsychosocial	**Engel, 1977**	Interaction de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux	–
Santé ressource	**Charte d'Ottawa, 1986**	« Ressource de la vie quotidienne, et non le but de la vie » ; conditions préalables : paix, abri, éducation, nourriture, revenu, écosystème stable, ressources durables, justice sociale, équité	–
Capacité d'adaptation	**Huber et coll., BMJ, 2011**	« Capacité à s'adapter et à se prendre en charge face aux défis sociaux, physiques et émotionnels »	–
Une seule santé (One Health)	Principes de Manhattan **2004** ; définition **OHHLEP 2021**, adoptée par la **Quadripartite** (OMS, FAO, OMSA, PNUE) ; plan d'action 2022-2026	Santé humaine, animale et des écosystèmes **interdépendantes** ; l'alimentation durable est au carrefour des trois	–

Définition de l'OMS (à citer mot pour mot) : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »

One Health (OHHLEP 2021) : « Une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. »

Pourquoi One Health : environ **60 % des maladies infectieuses humaines viennent de l'animal** (zoonoses) ; l'antibiorésistance circule entre élevage, environnement et humains ; le climat modifie la production alimentaire. Le **guide BTS 2025** place toute intervention en nutrition dans cette approche. Exemple : menu végétarien hebdomadaire (EGalim) = plus de fibres (santé humaine), moins de gaz à effet de serre (écosystèmes), moins de pression sur l'élevage (santé animale).

1.2 Deux formules célèbres

- **René Leriche (1936)** : « La santé, c'est la vie dans le silence des organes » (vision biomédicale).

- **Georges Canguilhem (1943, *Le normal et le pathologique*)** : être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever, créer de nouvelles normes de vie (vision dynamique).

1.3 La santé est une notion relative

1. **Individuelle** : chacun juge sa santé selon son âge, son expérience, ses attentes.
2. **Variable** : selon les époques, les cultures, les groupes sociaux (être « bien en chair » était un signe de santé au XIXe siècle).
3. **Dynamique** : équilibre instable avec l'environnement, à reconquérir sans cesse (perte d'emploi, deuil…).

1.4 Santé objective, perçue, positive

- **Objective** : mesurée par des indicateurs (IMC, glycémie, mortalité).
- **Perçue** : déclarée par la personne (Baromètre de Santé publique France, enquête européenne EHIS) ; elle prédit la mortalité.
- **Positive** : bien-être, qualité de vie, santé mentale positive.
- Indicateurs de l'état de santé d'une population : natalité, mortalité, mortalité infantile, espérance de vie, prévalence, incidence, IDH. Producteurs : Insee, Drees, Santé publique France, ORS (détail au chapitre 2).

2. La santé publique (1.3.2)

2.1 Définitions

- **Winslow (1920)** : « La santé publique est **la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé** […] à travers **les efforts coordonnés de la communauté** » (assainir l'environnement, contrôler les infections, éduquer à l'hygiène, organiser les services médicaux, assurer à chacun un niveau de vie adéquat).
- **OMS (1952)** : reprend Winslow et ajoute la santé mentale et « le droit inné à la santé et à la longévité ».
- **Code de la santé publique, art. L. 1411-1** (loi du 26 janvier 2016) : la politique de santé relève de l'État ; elle vise la promotion de conditions de vie favorables, l'amélioration de l'état de santé, la **réduction des inégalités sociales et territoriales**, l'égalité femmes-hommes, la sécurité sanitaire, l'accès à la prévention et aux soins.
- Formule courte : ensemble des savoirs, savoir-faire et actions organisées pour maintenir et améliorer la santé **de la population**, en agissant **collectivement sur ses déterminants**.

2.2 Brève histoire

Période	Préoccupation	Repères
Antiquité – Renaissance	Survivre aux épidémies	Hippocrate (*Airs, eaux, lieux*) ; quarantaine à Raguse (1377) ; lazarets
XVIIIe siècle	La santé du peuple devient l'affaire de l'État	Premières statistiques ; vaccin antivariolique (Jenner, 1796)
XIXe siècle	Hygiénisme : la misère et l'eau sale tuent	Villermé (1840) ; Snow et le choléra de Londres (1854) ; Pasteur ; **loi du 15 février 1902** (première loi de santé publique)
XXe siècle	Protéger tout le monde, du curatif au préventif puis à la promotion	**Ordonnances de 1945** (Sécurité sociale, PMI) ; OMS (1948) ; **Alma-Ata (1978)** ; **Ottawa (1986)** ; loi du 1er juillet 1998 (veille sanitaire)
XXIe siècle	Sécurité sanitaire, droits des usagers, inégalités, territoires, climat	**Loi du 4 mars 2002** (droits des malades) ; **loi du 9 août 2004** (politique de santé publique) ; **loi HPST du 21 juillet 2009** (ARS) ; **loi du 26 janvier 2016** (modernisation, Nutri-Score) ; SNS 2018-2022 (projet 2023-2033 non adopté)

Les 5 lois à citer : 1902, 2002, 2004, 2009, 2016.

2.3 Approche clinique (BC1) contre approche de santé publique (BC3)

	Clinique	Santé publique
Cible	Un individu (patient)	Une population, un groupe
Point de départ	Demande de soin, prescription	**Diagnostic de situation** (données, besoins)
Objectif	Guérir, soulager	Maintenir et améliorer la santé du groupe, **réduire les inégalités**
Leviers	Bilan, diagnostic diététique, ETP	Environnements, politiques, éducation, partenariats, plaidoyer
Acteurs	Équipe soignante	Équipe pluridisciplinaire et **intersectorielle**
Évaluation	Évolution du patient	Indicateurs de processus et de résultats

2.4 Les 9 missions de la santé publique (OMS Europe)

1. Observer et surveiller ; 2. Veiller et alerter ; 3. Protéger (missions de **connaissance et défense**).
2. Promouvoir la santé ; 5. Prévenir ; 6. Éduquer et informer (missions d'**action** : c'est là qu'est le diététicien).
3. Organiser le système ; 8. Former, chercher, évaluer ; 9. Gouverner (missions de **cadre**).

2.5 Le paradoxe de la prévention (Geoffrey Rose, 1985)

Un grand nombre de personnes exposées à un petit risque produit plus de cas qu'un petit nombre de personnes à haut risque. Une mesure pour toute la population apporte beaucoup à la population mais peu à chaque individu.

Calcul type : 100 000 adultes ; 5 000 à haut risque (10 AVC pour 1 000) = 50 AVC ; 95 000 à faible risque (2 pour 1 000) = 190 AVC. Total 240 ; 190 / 240 = **79 % des cas dans le groupe « à faible risque »**. Conclusion : combiner **stratégie populationnelle** (moins de sel dans le pain) et **stratégie à haut risque** (dépistage).

Méthode de calcul : cas = effectif × taux / 1 000 ; part = cas du groupe / total × 100.

3. Problème de santé, danger, risque (1.3.3)

Notion	Définition	Exemple
Problème de santé	Situation qui altère ou menace la santé d'une population, mesurable (fréquence, gravité, coût)	Obésité infantile, dénutrition du sujet âgé
Danger	Agent ou situation **capable** de provoquer un effet néfaste (propriété intrinsèque)	*Listeria*, excès de sel, arachide
Exposition	Contact avec le danger (dose, durée, fréquence)	Pain et plats préparés salés tous les jours
Risque	**Probabilité** que l'effet néfaste survienne : **risque = danger × exposition**	Probabilité d'hypertension avec 8 g de sel/jour
Facteur de risque	Associé à une probabilité accrue de maladie, **pas forcément la cause**	Sédentarité, boissons sucrées, faible revenu
Facteur de protection	Associé à une probabilité réduite	Allaitement, fruits et légumes, activité physique, soutien social
Population à risque	Groupe plus exposé ou plus vulnérable	Femmes enceintes (listériose), personnes âgées isolées (dénutrition)

Chaîne du risque : danger → exposition → risque → problème de santé (mesuré par prévalence et incidence). Facteur de risque n'est pas cause : la causalité se discute avec les critères de **Bradford Hill** (chapitre 16).

4. Les modes d'intervention (1.3.4)

Le **guide 2025** retient **4 modes** : **surveillance et veille sanitaire ; promotion de la santé ; prévention ; éducation pour la santé**. Un bon projet les combine, mais il faut savoir nommer son action à l'oral E5.

4.1 Mode 1 – Surveillance et veille sanitaire

- **Surveillance** : collecte systématique et continue de données, analyse, interprétation et diffusion pour orienter l'action (définition des CDC).
- **Veille sanitaire** : détecter le plus tôt possible un **signal** anormal, l'évaluer et **alerter**. Confiée à **Santé publique France**, créée le **1er mai 2016** (fusion InVS + INPES + EPRUS + Adalis).
- Enquêtes en nutrition : **INCA** (ANSES ; INCA 3 en 2014-2015, publiée en 2017), **ESTEBAN** (Santé publique France, 2014-2016), **NutriNet-Santé** (depuis 2009), Baromètre de Santé publique France, enquêtes de santé scolaire de la Drees, **Albane** (Santé publique France + ANSES, lancée en juin 2025, tous les deux ans, premiers résultats début 2028).
- Veille sur les aliments : déclaration obligatoire des **TIAC** à l'ARS, **RappelConso** (avril 2021), **nutrivigilance** de l'ANSES (compléments alimentaires).

4.2 Mode 2 – La promotion de la santé

Définition (Charte d'Ottawa, 21 novembre 1986) : « **processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci** ». Elle ne vise pas une maladie : elle agit sur **tous les déterminants** et renforce le **pouvoir d'agir** (empowerment). Elle est positive et politique.

Charte d'Ottawa : 5 + 3

5 domaines d'action	Exemple en nutrition
1. Élaborer une **politique publique saine**	EGalim, Nutri-Score, SNANC
2. Créer des **milieux favorables**	Fontaines à eau, pas de distributeurs à l'école (loi 2004)
3. Renforcer l'**action communautaire**	Jardin partagé, épicerie solidaire co-gérée
4. Acquérir des **aptitudes individuelles**	Atelier cuisine, lecture d'étiquettes
5. **Réorienter les services** de santé	Prévention en MSP, CPTS, rendez-vous de prévention

Moyen mnémotechnique : « **P**our **M**anger **C**orrectement, **A**gissons **R**apidement ».

3 stratégies : **plaider** (convaincre les décideurs), **conférer les moyens** (habiliter), **servir de médiateur** (concilier les intérêts).

Conférences après Ottawa : Alma-Ata 1978 (soins de santé primaires, « la santé pour tous en l'an 2000 ») ; Adélaïde 1988 (politiques favorables, nutrition prioritaire) ; Jakarta 1997 (partenariats) ; Bangkok 2005 (mondialisation) ; Adélaïde 2010 et **Helsinki 2013** (santé dans toutes les politiques) ; Shanghai 2016 (ODD, villes-santé, littératie) ; Genève 2021 (bien-être, planète).

Principes d'action : agir sur les déterminants ; **participation** (faire *avec* les personnes) ; empowerment ; **intersectorialité** ; réduction des inégalités (universalisme proportionné) ; approche par **milieux de vie** (écoles promotrices de santé, Villes-Santé OMS, réseau français créé en 1990) ; **non-stigmatisation**.

Modèle des déterminants de Dahlgren et Whitehead (1991), numéroté **du centre (1) vers l'extérieur (5)** :

1. Âge, sexe, hérédité (non modifiables) ;
2. Style de vie personnel (alimentation, activité physique, tabac, alcool, sommeil) ;
3. Réseaux sociaux et communautaires ;
4. Conditions de vie et de travail (production alimentaire, éducation, travail, chômage, eau, services de santé, logement) ;
5. Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales.

Plus on agit sur les couches extérieures, plus on touche de monde et plus on réduit les inégalités.

Universalisme proportionné (Marmot, *Fair Society, Healthy Lives*, 2010) : actions **pour tous**, avec une **intensité proportionnelle au désavantage social**. Évite deux écueils : l'universel seul profite aux plus favorisés ; le ciblé seul stigmatise et oublie le **gradient social**. Exemple : cantine pour tous + tarification sociale (« cantine à 1 € », 2019) + accompagnement renforcé en QPV.

4.3 Mode 3 – La prévention

Définition (OMS, 1948) : « ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps ». Elle part toujours d'un **problème de santé défini**.

OMS (selon le moment)	Cible	Exemple nutrition
Primaire : avant la maladie	Baisse l'**incidence** (nouveaux cas)	Repères PNNS, atelier cuisine, allaitement, Nutri-Score, moins de sel dans le pain
Secondaire : début, souvent avant les symptômes	Baisse la **prévalence** (cas existants) par **dépistage** et prise en charge précoces	Courbes de corpulence en PMI (rebond d'adiposité), dépistage de la dénutrition en EHPAD, du diabète de type 2
Tertiaire : maladie installée	Réduit **complications, incapacités, récidives**	Prise en charge diététique du diabète, **ETP** (BC1)
Quaternaire (Jamoulle, 1986)	Évite la **surmédicalisation**	Pas de régimes restrictifs, compléments ou exclusions inutiles

Gordon, 1983 (selon le public)	Public	Exemple
Universelle	Toute la population	Campagne « Manger Bouger », menu végétarien à l'école
Sélective	Sous-groupe exposé à un risque, sans signe	Ateliers petit budget en QPV, « 1000 premiers jours » en précarité
Indiquée (ciblée)	Personnes ayant déjà des facteurs de risque ou signes précoces	Enfants en surpoids repérés (« Mission : retrouve ton cap »)

Attention : ces deux classifications sont **indépendantes** (pas de correspondance case à case entre les colonnes).

Troisième classification : **prévention globale** (Robert San Marco, 2003), centrée sur la personne et sa qualité de vie, proche de la promotion de la santé.

4.4 Mode 4 – L'éducation pour la santé

Définition (Plan national d'éducation pour la santé, 2001) : que chaque citoyen acquière, tout au long de sa vie, **les compétences et les moyens lui permettant de promouvoir sa santé et sa qualité de vie ainsi que celles de la collectivité**. Elle respecte la liberté des personnes (choix éclairés).

3 formes (guide BTS 2025)	Contenu	Exemple
Nutritionnelle	Nutriments, besoins, repères	Lire une étiquette, comprendre le Nutri-Score
Alimentaire	Choisir, acheter, cuisiner, budget, gaspillage, dimension culturelle	Atelier « repas complet à moins de 2 € », visite de marché
Sensorielle (éducation au goût)	Cinq sens, vocabulaire, plaisir, lutte contre la néophobie	Classes du goût (**Jacques Puisais, 1975**), **Semaine du goût** (depuis 1990, octobre)

Approche	Principe	Limite
Informative	Transmettre des connaissances	Savoir ne suffit pas à changer
Persuasive	Convaincre, parfois par la peur	Culpabilise, stigmatise, creuse les inégalités
Participative (à privilégier)	Partir des représentations, développer compétences et pouvoir d'agir	Plus longue, demande des compétences d'animation

Compétences psychosociales (CPS) : référentiel de Santé publique France (2022) ; stratégie nationale CPS des enfants et des jeunes (**2022-2037**).

Marketing social (« 4 P » : produit, prix, distribution, communication ; ex. Change4Life) et **nudges** (Thaler et Sunstein, 2008 : fruits à hauteur des yeux, eau par défaut) : utiles, mais ne remplacent pas l'action sur les déterminants structurels.

4.5 Les deux modes « en plus » (CNED, manuels)

- **Sécurité sanitaire** : protéger contre les risques (aliments, eau, produits) : **veille → expertise → gestion → communication** ; principe de précaution (Charte de l'environnement, 2005, art. 5). Se range dans le mode 1 (détection) et la mission « protéger ».

- **Restauration de la santé** : rétablir la santé quand la maladie est installée (soins, réadaptation, ETP) : **hors BC3**, c'est le soin (BC1, BC2), prévention tertiaire.

Chaîne d'une TIAC (au moins **2 cas groupés**, mêmes symptômes, même origine alimentaire) : médecin → déclaration à l'**ARS** → enquête ARS + **DDPP/DDETSPP** ; Santé publique France analyse ; laboratoire (plats témoins conservés **5 jours**) → **ANSES** évalue → préfecture ou ministère décide le retrait ou le rappel (**RappelConso**).

4.6 Emboîtement des notions

Promotion de la santé (la plus large) ⊃ **prévention** ⊃ **éducation pour la santé** (moyen de la prévention et de la promotion). L'**ETP** est **à part, du côté du soin**.

	Promotion	Prévention	Éducation pour la santé	ETP (BC1)
Cible	Population, milieux, décideurs	Groupe exposé à un problème	Personnes **bien portantes**	**Patients** atteints de maladie chronique
Objectif	Santé, bien-être, pouvoir d'agir, inégalités	Éviter ou réduire un problème défini	Connaissances, compétences, attitudes	Autosoins, adaptation à la maladie
Point de départ	Déterminants	Maladie ou facteur de risque	Besoins éducatifs	Diagnostic éducatif (bilan éducatif partagé)
Cadre	Ottawa, SNS, PRS	OMS 1948, Gordon 1983	PNES 2001	**Loi HPST 2009** (art. L. 1161-1 CSP), HAS 2007, programmes **déclarés à l'ARS**

4.7 Méthode express : qualifier son action en 4 phrases (oral E5)

1. **Mode** : « Mon projet est une action d'éducation pour la santé (alimentaire / nutritionnelle / sensorielle)… »
2. **Prévention** : « … au service de la prévention primaire, sélective, car le public… »
3. **Promotion** : « Il s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé car… (participation, milieu favorable, partenariat). »
4. **Politiques** : « Il répond à l'axe … du PNNS 5 (2026-2030), à l'objectif … du PRS et à la fiche-action … du CLS. »

5. Les acteurs (1.3.5)

5.1 Quatre types d'acteurs (CNED)

Type	Rôle	National	Régional / local
Décideur	À l'origine des décisions	Parlement, Gouvernement, ministère de la Santé (**DGS**), de l'Agriculture (**DGAL**)	ARS (PRS), conseil départemental (PMI), commune (cantine)
Consultatif	Consulté avant la décision	**HCSP**, Conférence nationale de santé (**CNS**), **CNA**	**CRSA**, conseils territoriaux de santé
Opérateur	Met en œuvre	Santé publique France, Assurance maladie, associations	Collectivités, CCAS, PMI, écoles, centres sociaux, **diététiciens**
Financeur	Apporte l'argent	Assurance maladie (**FNPEIS**), État	ARS (**FIR**, fonds d'intervention régional), départements, régions, communes, mutuelles, fondations

Un même acteur peut avoir plusieurs rôles (l'ARS décide, finance et pilote). Sigles à jour : **HCSP** (depuis 2004, ex-« Haut Comité »), **CRSA** (depuis 2009, ex-CRS), **territoires de démocratie sanitaire** et **conseils territoriaux de santé** (depuis 2016, ex-« territoires de santé »).

5.2 International et européen

- **OMS** (Genève, 1948) : normes (**sucres libres < 10 %** de l'énergie, idéalement < 5 % ; **sel < 5 g/j** ; **allaitement exclusif 6 mois**) ; bureau Europe à Copenhague.
- **FAO** (Rome, 1945) : sécurité alimentaire ; CIN2 (Rome 2014) ; Décennie pour la nutrition 2016-2025.
- **Codex alimentarius** (FAO/OMS, 1963) : normes alimentaires internationales.

- **UNICEF** : nutrition mère-enfant, « Hôpital ami des bébés ».
- **ODD 2030** : ODD 2 « Faim zéro », ODD 3 « Bonne santé », ODD 12 « Consommation responsable ».
- **Commission européenne (DG SANTE)** : règlement **INCO 1169/2011** (déclaration nutritionnelle, **14 allergènes**) ; règlement **1924/2006** (allégations).
- **EFSA** (Parme, 2002) : évaluation des risques, valeurs de référence. **RASFF** : alertes entre États. **EUFIC** : en partie financé par l'industrie (conflits d'intérêts).

5.3 National

- **DGS** : pilote la santé publique et le **PNNS**. **DGAL** : pilote le **PNA**, sécurité des aliments, EGalim, « ma cantine ». **DGCCRF** : étiquetage, loyauté, RappelConso. Éducation nationale : « Écoles promotrices de santé ». Transition écologique : copilote de la SNANC, loi AGEC.
- **Santé publique France (2016)** : surveillance, veille, prévention ; « Manger Bouger » ; gestion du Nutri-Score ; registre des interventions probantes ; Géodes.
- **ANSES (2010)** : évaluation des risques ; références nutritionnelles ; **INCA** ; **table Ciqual** ; **Oqali** (avec INRAE) ; nutrivigilance.
- **HAS (2004)** : recommandations (surpoids de l'enfant 2022 ; dénutrition : **HAS + FFN 2019** pour l'enfant et l'adulte, **HAS + FFAMCO 2021** pour les 70 ans et plus), ETP.
- **HCSP (2004)** : avis (repères adultes 2017, enfants 2020, **PNNS 5 en juin 2025**), évaluation des plans.
- **CNA (1985)** : instance de concertation entre production, distribution, consommateurs, santé.
- INCa (cancers, réseau NACRe) ; Assurance maladie (prévention, SNDS) ; recherche : Inserm, INRAE, **EREN** (NutriNet-Santé).

Producteurs de données (à connaître) : **Insee** (démographie, pauvreté) ; **Drees** (état de santé, santé scolaire) ; **CépiDc-Inserm** (causes de décès) ; **Santé publique France** (ESTEBAN, Baromètre, Géodes, Albane) ; **ANSES** (INCA, Ciqual, Oqali) ; **Assurance maladie** (SNDS, ALD) ; **ORS/FNORS** (Score-santé) ; **Crédoc** (consommation, précarité) ; **Inserm/EREN** (NutriNet-Santé).

5.4 Régional et local

- **ARS** (loi HPST 2009, créées en 2010) : élabore le **PRS**, finance (**FIR**), lance des **appels à projets**, signe les **CLS**, autorise les établissements, reçoit les **déclarations d'ETP**, coordonne la veille (TIAC).
- **CRSA** : « parlement régional de la santé », avis sur le PRS. **DRAAF** : décline le PNA, reconnaît et finance les **PAT**. **DREETS/DDETS** : aide alimentaire (« **Mieux manger pour tous** », 2023). Conseil régional : lycées. **Promotion Santé** (ex-IREPS) : appui méthodologique, outils. **ORS** : portraits de territoire. CSO (centres spécialisés de l'obésité).
- **Département** : **PMI**, action sociale, APA, collèges. **Communes** : cantine primaire, **CCAS** (épiceries sociales, portage de repas), ateliers santé ville, CLS, PAT, contrats de ville (« Engagements Quartiers 2030 »). **CAF** : centres sociaux. Santé scolaire, CESCE. **MSP, CPTS**, centres de santé. Associations (Banques alimentaires, Restos du cœur…), mutuelles, entreprises, diététiciens.

5.5 La démocratie sanitaire

Définition : associer tous les acteurs, en particulier les **usagers**, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé. Texte fondateur : **loi Kouchner du 4 mars 2002** (après l'affaire du sang contaminé), complétée en 2009 et 2016.

Droits individuels	Droits collectifs
Accès aux soins et à la prévention sans discrimination	Représentation par des associations agréées
Dignité, vie privée, secret	Représentants dans les établissements (commission des usagers)
Information, **consentement libre et éclairé**	Participation aux instances nationales, régionales, territoriales
Accès direct au dossier médical	Participation à l'élaboration des politiques (avis sur le PRS)
Prise en charge de la douleur, personne de confiance	**France Assos Santé** (loi 2016, active depuis 2017)

Instances : national = **Conférence nationale de santé** ; régional = **CRSA** ; territorial = **conseil territorial de santé** ; établissement = **commission des usagers (CDU)**.

6. Les politiques publiques de santé (1.3.6)

Politique publique : ensemble coordonné de décisions et d'actions des pouvoirs publics pour répondre à un problème reconnu comme public, avec objectifs, moyens et acteurs.

Outil	Définition	Exemple
Loi	Votée par le Parlement, obligatoire	Loi du 9 août 2004 (interdiction des distributeurs automatiques dans les écoles, PNNS dans la loi) ; EGalim 2018 ; Climat et résilience 2021
Règlement (décret, arrêté)	Texte du Gouvernement qui applique une loi	Arrêté Nutri-Score du 31/10/2017 modifié le **14/03/2025** ; décret du 30/09/2011 (repas scolaires)
Stratégie	Cadre pluriannuel, orientations	SNS (dernière adoptée **2018-2022**) ; **SNANC 2025-2030**
Plan / programme	Déclinaison opérationnelle (actions, pilotes, calendrier, indicateurs)	**PNNS 5**, **PNA 4** (2026-2030)
Financement	Crédits	FIR des ARS, appels à projets PNA, « Mieux manger pour tous »

6 étapes d'une politique : **mise à l'agenda** (ex. obésité infantile → PNNS 1 en 2001) → **élaboration** (experts, concertation, consultation) → **décision** → **mise en œuvre** → **pilotage et suivi** → **évaluation** (HCSP, IGAS, Cour des comptes), qui prépare le plan suivant.

Organisation : loi du **26 janvier 2016** (prévention prioritaire ; **art. 14 : Nutri-Score, facultatif**). **SNS** (art. L. 1411-1-1 CSP) : dernière adoptée **2018-2022** (décret du 29/12/2017) ; le **projet 2023-2033** (consultation à l'automne 2023) **n'était pas adopté au 12 mai 2026** : le présenter comme un projet. Comité interministériel pour la santé (2014). Agences : Santé publique France, ANSES, HAS.

Vocabulaire de la planification : priorité sanitaire ; plan ou programme (en général 4 à 5 ans) ; **planification sanitaire** (prévoir les actions par ordre de priorité, dans le cadre de la SNS ; conduite par l'ARS via le PRS) ; **territoire de démocratie sanitaire** (arrêté par l'ARS depuis 2016).

Double logique : **descendante** (SNS → PRS → CLS → fiche-action) et **ascendante** (diagnostics locaux, besoins des habitants, avis des instances). Un bon dossier montre les deux.

Données : **SNDS** (loi 2016 ; Assurance maladie + PMSI + CépiDc ; géré par la Cnam) ; **Health Data Hub** (loi du 24 juillet 2019, remplace l'INDS). Attention : une donnée de remboursement **ne compte que les personnes traitées** ; l'obésité se mesure par des **enquêtes** (ESTEBAN, OFÉO).

Déclinaison territoriale :

- **PRS** (art. L. 1434-1 CSP), élaboré par l'ARS = **COS (10 ans) + SRS (5 ans) + PRAPS** (plus démunis). PRS de 3e génération : 2023-2028.
- **CLS** (art. L. 1434-10 CSP) : contrat **ARS + collectivité** pour appliquer le PRS au plus près des habitants.
- **PAT** (loi d'avenir pour l'agriculture du **13 octobre 2014**) : rapproche producteurs, distributeurs, collectivités et consommateurs ; **≈ 450 PAT reconnus** au 1er juillet 2025 ; objectif SNANC **80 % du territoire couvert**.
- **Contrat de ville** (QPV, « Engagements Quartiers 2030 », 2024-2030), atelier santé ville ; CLSM, CPTS, MSP.

Architecture 2026 : **mondial/européen** (OMS, FAO, ODD, UE) → **national-stratégies** (SNS, SNANC) → **national-programmes** (PNNS 5, PNA 4, lois, règlements) → **régional** (ARS-PRS, DRAAF, Promotion Santé, ORS) → **local** (CLS, PAT, contrats de ville, communes, CCAS, PMI, écoles, associations, diététicien).

7. Les politiques nutritionnelles (1.3.7)

7.1 Chiffres-clés (avec source)

Indicateur	Valeur
Obésité adulte (déclarée)	**18,1 %** (OFÉO 2024) ; 22,4 % outre-mer ; 17,9 % hexagone ; 24,7 % si difficultés économiques
Surpoids et obésité mesurés, 18-74 ans	**49 % dont 17 % d'obésité** (ESTEBAN 2015)
Enfants 6-17 ans	**17 % de surpoids dont 4 % d'obésité** (ESTEBAN 2015)

Indicateur	Valeur
5 fruits et légumes/jour	**30 % des adultes, 20 % des enfants** (HCSP 2025)
Fibres < 25 g/j	**90 % des adultes** (HCSP 2025)
Viande rouge > 500 g/sem	4 hommes sur 10, 1 femme sur 4 (HCSP 2025)
Sel	≈ 9 g/j (hommes), 7 g/j (femmes) (INCA 3, 2017) ; repère OMS < 5 g
Activité physique	42 % des 6-17 ans à 60 min/j (2016) ; 1 adulte sur 3 assis > 7 h/j (2024)
Précarité alimentaire	**16 %** en 2022 contre 9 % en 2016 (Crédoc)
Espérance de vie 2025	**85,9 ans (F), 80,3 ans (H)** (Insee)
Inégalités	**≈ 13 ans** d'écart entre les 5 % d'hommes les plus aisés et les plus modestes (Insee 2018)
Vieillissement	22,2 % de 65 ans et plus au 1er janvier 2026

Bien lire un chiffre : **année de recueil, population, méthode (mesuré ou déclaré), source**. 17 % (ESTEBAN, mesuré) et 18,1 % (OFÉO, déclaré) ne sont pas comparables.

7.2 Frise des politiques nutritionnelles

Date	Texte
2001-2005	**PNNS 1** (9 objectifs chiffrés ; guide « La santé vient en mangeant », 2002)
2004	Loi du 9 août 2004 : PNNS dans la loi ; **distributeurs interdits à l'école** (2005) ; messages sanitaires sur les publicités (2007)
2006-2010	**PNNS 2** : offre alimentaire, chartes des industriels, Oqali (2008)
2010	Loi de modernisation de l'agriculture (27 juillet) : création du **PNA** ; Plan obésité 2010-2013
2011-2015 (prolongé 2018)	**PNNS 3** : inégalités, activité physique, dénutrition
2016	Loi de modernisation : base légale du **Nutri-Score** (arrêté du **31 octobre 2017**)
2017	Avis HCSP sur les repères ; résultats INCA 3 et ESTEBAN
2018	**Loi EGalim** (30 octobre)
2019-2023	**PNNS 4** : 5 axes, 55 actions ; repères Santé publique France (janvier 2019) ; PNA 3 ; PNNS 4 + PNA 3 = **PNAN**
2021	**Loi Climat et résilience** (22 août), **art. 265 : SNANC** ; menu végétarien hebdomadaire pérennisé
2025	Avis HCSP pour le PNNS 5 (juin) ; **nouvel algorithme Nutri-Score (14 mars)** ; enquête Albane (juin)
2026	**SNANC 2025-2030 publiée le 11 février 2026** ; **PNNS 5 et PNA 4 lancés le 8 avril 2026** (One Health Summit, Lyon)

Évolution : d'une politique de **messages** (PNNS 1) à une politique qui agit sur l'**environnement alimentaire et le climat**.

7.3 SNANC 2025-2030

Prévue par l'**article 265 de la loi Climat et résilience (2021)**, attendue en 2023, publiée le **11 février 2026**. Elle **détermine les orientations du PNNS et du PNA**. Trois enjeux : **santé publique, transition écologique, souveraineté alimentaire**. Trois axes : 1) accès de tous à une alimentation plus saine ; 2) réduire l'impact de l'alimentation sur le climat ; 3) soutenir les agriculteurs et les filières. Objectif : **80 % du territoire couvert par des PAT**.

7.4 PNNS 5 (2026-2030)

- Piloté par la **DGS**, en lien avec le PNA 4.

- **3 axes** : 1) garantir à tous l'accès à des **environnements nutritionnels durables** favorables à la santé ; 2) encourager des **comportements nutritionnels sains et durables** ; 3) faire des **milieux de vie des espaces promoteurs de santé** (formulation officielle ; le cours la résume aussi en « mobilisation des milieux de vie et des acteurs clés »).
- **20 mesures** (contre 55 actions dans le PNNS 4).
- Objectifs : **− 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants et adolescents** (**− 20 %** chez les plus défavorisés) ; 12 % de bio ; 40 % des Français utilisant le Nutri-Score ; 75 % des produits transformés affichant le Nutri-Score ; 85 % d'enfants allaités à la naissance.
- Mesures phares : protéger les enfants du marketing (charte ARCOM 2025-2029) ; moins de sucres dans les produits pour enfants ; Nutri-Score étendu ; 1000 premiers jours ; dénutrition des personnes âgées ; nouvelles recommandations.
- Ce qui change : l'activité physique passe surtout à la **Stratégie nationale sport-santé** ; l'obésité à une feuille de route dédiée ; les **ultra-transformés** reconnus comme enjeu (l'ANSES doit les définir).

7.5 PNA 4 (2026-2030)

Piloté par le **ministère de l'Agriculture** (PNA créé en 2010) : offre alimentaire, restauration collective, gaspillage, éducation alimentaire, justice sociale ; soutient les PAT ; appels à projets via les DRAAF.

7.6 Repères alimentaires adultes (Santé publique France, janvier 2019)

- **Augmenter** : fruits et légumes (**au moins 5 portions/j**, 80 à 100 g) ; **légumes secs au moins 2 fois/semaine** ; **fruits à coque** sans sel (une petite poignée/j) ; **activité physique 30 min/j**.
- **Aller vers** : féculents complets (au moins 1/j) ; huiles de **colza, noix, olive** ; **poisson 2 fois/semaine dont 1 gras** ; **2 produits laitiers/j** ; saison, local, bio ; fait maison.
- **Réduire** : alcool (**max 10 verres/semaine, 2/jour**, jours sans) ; boissons sucrées (**max 1 verre/j**) ; produits gras, sucrés, salés, ultra-transformés ; **charcuterie 150 g/semaine** ; **viande hors volaille 500 g/semaine** ; sel ; temps assis.
- Repères spécifiques : enfants 0-17 ans (HCSP 2020), femmes enceintes et allaitantes, personnes âgées (ANSES 2019).

7.7 Autres leviers

- **EGalim** (loi du 30 octobre 2018, + Climat et résilience) en restauration collective : **au moins 50 % de produits durables et de qualité dont au moins 20 % de bio** (valeur d'achat HT, depuis le 1er janvier 2022) ; **60 % pour viandes et poissons** depuis 2024 (100 % pour l'État) ; **menu végétarien hebdomadaire** à l'école ; plan de diversification des protéines (> 200 couverts/j) ; télédéclaration sur « **ma cantine** ». Bilan achats 2023 : **≈ 25,5 % durables, 12,1 % bio** (objectifs non atteints).
- **Nutri-Score** : 5 lettres A à E ; développé par l'**EREN** ; adopté le 31/10/2017 ; **facultatif** (le droit européen interdit de l'imposer) ; 7 pays ; nouvel algorithme (**arrêté du 14/03/2025**, 2 ans de transition) : mieux classe huiles insaturées, poissons gras, céréales complètes ; plus sévère pour sel, sucre, boissons édulcorées ; **seule l'eau est A** parmi les boissons.
- **Fiscalité** : contribution sur les boissons sucrées (2012), progressive depuis 2018, renforcée en 2025 ; boissons édulcorées taxées.
- **Marketing** : loi du 20 décembre 2016 (pas de pub dans les programmes jeunesse de la TV publique depuis 2018) ; charte ARCOM 2025-2029.
- **1000 premiers jours** (2020, commission Cyrulnik). **Mieux manger pour tous** (2023). Cantine à 1 € et **petits-déjeuners gratuits** en territoires prioritaires (2019) ; « lait et fruits à l'école ». Chartes **Villes / Départements / Entreprises actives PNNS**.

Calcul EGalim : taux = achats de la catégorie / achats totaux × 100 (le bio compte dans les « durables »). Exemple : 120 000 € dont 18 000 € bio, 21 000 € Label rouge/AOP/IGP, 6 000 € écolabel pêche → bio 15 % (< 20 %) ; durables 45 000 / 120 000 = 37,5 % (< 50 %) : non conforme.

8. Le diététicien en santé publique (1.3.8)

Art. L. 4371-1 CSP : le diététicien dispense des conseils nutritionnels, participe sur prescription à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients, contribue à la qualité de l'alimentation en collectivité **et aux activités de prévention en santé publique** dans le champ de la nutrition. **Titre protégé** (BTS Diététique et nutrition, BUT Génie biologique parcours diététique ; enregistrement ADELI puis **RPPS**) ; « nutritionniste » n'est pas protégé.

Missions (guide AFDN 2022) : diagnostic nutritionnel d'un territoire ; concevoir, coordonner, animer, évaluer des projets ; créer des outils (littératie) ; **former des relais** ; **conseiller les décideurs** ; participer aux études ; assurer une veille ; participer aux réseaux (CLS, PAT).

Employeurs : collectivités, centres sociaux, associations, Promotion Santé, mutuelles, Assurance maladie, entreprises, Éducation nationale, clubs sportifs, libéral (conventions).

Posture : respecter cultures et contraintes ; ne pas culpabiliser ; partir des besoins ; travailler en partenariat ; informations **validées, datées, sourcées** ; pas de conflit d'intérêts ; secret et **RGPD** (droit à l'image).

Ce qu'il ne fait pas : poser un diagnostic médical ; prescrire un régime à un participant d'atelier (orienter vers une consultation) ; promouvoir une marque ; diffuser des photos sans autorisation écrite.

9. La démarche de projet (fil rouge 1.3.9)

Projet (Afnor, NF EN ISO 9000) : « processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant une date de début et une date de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conformément à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources ». Un projet de santé publique part d'un **diagnostic partagé**, vise une **population** et est **évalué** (y compris sur les inégalités).

Vocabulaire : **projet** (ensemble coordonné d'actions sur une durée) ⊃ **action** (répond à un objectif opérationnel) ⊃ **atelier** (une séance concrète). Un atelier isolé **n'est pas** un projet. Appel à projets ; parties prenantes (équipe, partenaires, usagers) ; valorisation ; capitalisation.

Les 6 étapes et les 14 fiches-outils :

1. **Analyse de situation et diagnostic** : F1 (diagnostic), F2 (**arbre à problèmes**).
2. **Priorités et objectifs** : F3 (**arbre à objectifs**, objectifs **SMART**).
3. **Conception** : F4 (fiche projet), F5 (planning **Gantt**), F6 (budget).
4. **Mise en œuvre et pilotage** : F7 (conducteur de séance), F8 (fiche technique d'atelier), F9 (grille de dégustation), F10 (communication).
5. **Évaluation** : F11 (questionnaire), F12 (tableau de bord).
6. **Valorisation** : F13 (veille), F14 (auto-évaluation). La démarche est un **cycle**.

Besoins de Bradshaw (1972) : **normatif** (défini par un expert selon une norme) ; **ressenti** (perçu par la population, pas forcément dit) ; **exprimé** (ressenti devenu demande) ; **comparatif** (par comparaison avec un groupe qui a déjà un service). Les besoins ressentis sont **ceux de la population**, jamais « des professionnels ». Un besoin présent dans plusieurs cases est prioritaire. On y ajoute les besoins **observés**.

Données « froides » (statistiques, rapports) et **« chaudes »** (questionnaires, entretiens, observations). Outils : QQOQCP, arbres, Ishikawa, SWOT, champs de forces (Lewin), carte mentale.

SMART : **S**pécifique, **M**esurable, **A**tteignable, **R**éaliste (pertinent), **T**emporel. Hiérarchie : objectif **général** (long terme) → **spécifiques** → **opérationnels**.

Fil rouge (fictif) : centre social des Tilleuls, Valmont (QPV, 4 200 habitants) ; étudiante Inès ; projet « Bien manger, petit budget, grand plaisir » ; 6 ateliers de 3 h pour 12 familles ; subvention ARS de 1 500 € ; repas complet à **1,38 €/personne** ; score de connaissances **4,75 → 7,17/10** ; légumes secs **25 % → 75 %** des familles.

Calculs utiles : coût d'un ingrédient = quantité (g) / 1 000 × prix (€/kg) ; coût par portion = coût total / nombre de portions ; taux d'atteinte d'un indicateur = réalisé / prévu × 100 ; moyenne = somme / effectif ; médiane = valeur du milieu de la série ordonnée ; écart-type $s = \sqrt{[\ \Sigma(x - \text{moyenne})^2 / (n - 1)\ ]}$.

10. Approfondissements (1.4 et 1.5)

- **Données probantes** : recherche + expérience des professionnels + savoirs des personnes. Registre des interventions probantes de Santé publique France. Méthode : chercher → vérifier → juger la **transférabilité** (garder les « fonctions clés ») → citer. Les actions **multi-composantes** (éducation + environnement + familles) marchent mieux que l'information seule.
- **Changement de comportement** (chapitre 3) : **Health Belief Model** (Rosenstock) ; **modèle transthéorique** (Prochaska et DiClemente, 1983 : précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien) ; **théorie sociale cognitive** (Bandura : **sentiment d'efficacité personnelle**).
- **Ultra-transformés** : classification **NOVA** (Monteiro, 2009) en 4 groupes (1 peu transformés ; 2 ingrédients culinaires ; 3 transformés ; 4 ultra-transformés). Le Nutri-Score mesure la **composition**, NOVA le **degré de transformation**, le bio le **mode de production**.

- **Non-stigmatisation du poids** (consensus *Nature Medicine* 2020) : dire « personne vivant avec une obésité » ; « bien manger et bouger en famille » plutôt que « lutter contre l'obésité » ; « aliments à limiter » plutôt que « interdits » ; ne pas peser les enfants en public ; actions pour tous.
- **Alimentation et climat** : ≈ **un quart de l'empreinte carbone** des ménages ; **co-bénéfices** santé-climat ; EAT-Lancet (2019) ; HCSP 2025 : environ **− 50 % de viande**. 20 g de protéines = 85 g de steak haché ≈ **200 g de lentilles cuites** (Ciqual 2025), qui apportent en plus 16,7 g de fibres et 4,9 mg de fer (non héminique : ajouter de la vitamine C).
- **Niveau L3** : capabilités (**Amartya Sen**) et sécurité sociale de l'alimentation ; **syndémie mondiale** (Swinburn, *Lancet* 2019 : obésité + dénutrition + climat) ; **évaluation réaliste** (Pawson et Tilley, 1997 : contexte – mécanisme – effet) ; santé dans toutes les politiques et **déterminants commerciaux de la santé** (OMS, *Lancet* 2023).

11. Les pièges classiques

- Citer le **PNNS 4** comme en vigueur : c'est le **PNNS 5 (2026-2030)**.
- Présenter la **SNS 2023-2033** comme adoptée : c'est un **projet** (dernière adoptée 2018-2022).
- Dire que le **Nutri-Score est obligatoire** : il est **facultatif**.
- Classer le **dépistage** en prévention primaire : c'est la **secondaire**.
- Appeler « éducation pour la santé » un atelier pour des **patients d'un programme ETP** : c'est de l'**ETP** (BC1, tertiaire).
- Confondre **incidence** (nouveaux cas) et **prévalence** (cas existants).
- Comparer des chiffres **mesurés** et **déclarés**.
- Écrire « besoins ressentis par les professionnels ».
- Appeler « projet » un simple atelier.
- Proposer **uniquement de l'information** sans agir sur les déterminants.
- Croire qu'une action universelle est forcément équitable.
- Attribuer la recommandation dénutrition des **70 ans et plus** à la FFN : c'est **HAS + FFAMCO (2021)** ; HAS + FFN = 2019 (enfant et adulte).
- Utiliser d'anciens sigles (Haut Comité, CRS, territoires de santé).